

Pasuruan, 7 Agustus 2025

Nomor : 1273/RSPHS/E-PTR/DIR/VIII/2025
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Pengantar Dokumen

Kepada Yth.
Bidan Desa Pakijangan
di Tempat

Dengan hormat,
Menindaklanjuti Permintaan Kronologi atas nama By Ny Siti Nur Fadila dari Bidan Desa Pakijangan Wonorejo, maka bersama dengan surat ini kami lampirkan kronologi kejadian sebagaimana terlampir.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kesediaan serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Sukorejo,



Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep., M. Kep

KRONOLOGI BY NY Siti Nur Fadila

Tanggal	Tindakan
28/7/2025 19:23	Assalamualaikum dokter izin konsul pasien datang sendiri ke IGD, riwayat periksa dg dr Rudi Sp.OG di RSPHS 🙏 Ny. Siti Nur Fadila /22th/UHC Subyektif Pasien mengatakan tadi sore sudah periksa ke Poli obgyn, dikatakan ketuban keruh dan letak lintang, di rencanakan operasi SC besok, kenceng2 sudah 3 hari ini. Darah (-) lendir (-). Mata minus 4 Pasien mengatakan tadi sore sudah periksa ke Poli obgyn, dikatakan ketuban keruh dan letak lintang, di rencanakan operasi SC besok, kenceng2 sudah 3 hari ini. Darah (-) lendir (-). Mata minus 4 Obyektif HPHT : 29/11/2024 TP : 5/9/2025 Alergi : - RPD : - RPK : - RPO : - Riw. Operasi : - Riw. Transfusi : - KU : cukup/ 456 TD: 120/80 mmHg RR: 20x/m N: 88x/mnt S: 36,5 °C SpO2 : 99 % RA BB:72 cm TB : 150cm Riwayat obstetri 1. abortus (tidak curretage) 2024 2. hamil ini TFU : 27 cm Letak : lintang VT : tidak ada pembukaan DJJ : 138 x/m HIS : 1.10.10" Penunjang DL, GDA, FH Assesment G1P0Ab0 uk 36-37 mg dg letak lintang Terapi IGD IVFD RL 20tpm

29/07/2025 14.15	Lapor By ny Siti Nur Fadila a/i ibu G2P0Ab1 UK 36-37 minggu dg letak lintang lahir secara Sc pukul 14.15 WIB JK : laki laki BB: 2450 gram PB: 46 cm Lk: 34 cm Ld: 28 cm A-S: 4-6 Ketuban: Jernih Tangis (-) Anus (+) Salep mata (-) Cacat (-) BAB (-) BAK (-) Vit K (+) Caput (-) Retraksi (-) Sesak (-) Sianosis (+) Merintih (-) Kemerahan (-) Tindakan yang telah dilakukan -Bagging bayi selama 10menit -Suction bayi TTV post resusitasi: Nadi: 126 x/ menit Suhu: 36,7 Rr: 62 x/ menit Spo2: 98 % on nasal 1 lpm Retraksi (+) Sesak (+) Merintih (+)
14.30	Transfer pasien dari IKO ke NICU Pasien rawat dalam incubator transport dengan terpasang O2 NC 1 lpm K/U lemah tangis lemah (+) retraksi(+) sesak(+) kemerahan (+) Observasi TTV: N: 137 S:36,8 C RR: 56x/mnt Spo: 97% on NC 1 lpm Lapor kondisi bayi vidio klinis via What App digrup DPJP Kondisi klinis: K/U lemah tangis lemah(+) kemerahan (+) retraksi min(+)



	sesak(+) N: 127x/mnt S: 36,7 C RR: 58x/mnt Spo2 97% on NC 1 lpm
15:40	Lapor kembali DPJP Kondisi Bayi+ Video Klinis via What App pribadi Kondisi klinis : K/U lemah tangis lemah (+) sesak(+)kemerahan (+) retraksi min (+) N: 138x/mnt S: 36,7 C RR:56x/mnt Spo: 98% on NC 1 lpm
16.08	DPJP ADVICE : - O2 CPAP (modif) PEEP 7 flow 7 lpm - IVFD D10 200 cc/hari - IV cefotaxim 2 x 125 mg - IV gentamisin 1 x 15 mg - Pasang OGT - Puasa sementara - Foto babygram - DL, GDA - IM HB0 tunda - Termoregulasi di inkubator - Dx: - NP-SC - BBLR - obs. distress napas ok neonatal pneumonia dd RDS
16.08	Injeksi Cefotaxim 125mg IV
17.00	Injeksi gentamicin 5 mg IV Lapor kondisi bayi ke DPJP TTV: k/u lemah Nadi: 154 x/ menit Suhu: 36,9 RR: 67 x/ menit Spo2: on O2 CPAP 58 % tangan kanan 53 % tangan kiri Sianosis (+), retraksi (+), saturasi turun hingga 59% GDA : 109mg/DI Tindakan yang dilakukan: Pasang Neopuff 30% PEEP 5
18:58	Balasan DPJP : Coba VTP 1 menit menggunakan O2 10 LPM

19.02	Lapor kondisi bayi TTV : N : 156 x/mnt RR : 67 x/mnt S : 36,8 C SPO2 : 98% on VTP 10LPM (Tangan Kanan) 98 % on VTP 10LPM (Kaki Kiri) Sesak (+), retraksi (+), merintih (+) Lapor hasil DL dan GDA bayi Hb : 13,5 g/dl Trombosit : 208.000 Leukosit : 15.700 Eosinofil : 3 Basofil : 1 Neutrofil : 60 Limfosit : 22 Monosit : 14 GDA : 50 mg/dl
19.16	Balasan DPJP O2 Cpap Peep 8 Flow 8lpm Evaluasi ulang kondisi 1 jam lagi
19.27	lapor kondisi pasien ke DPJP : TTV: k/u lemah Nadi: 163 x/ menit Suhu: 36,9 RR: 68 x/MENIT Spo2: 86% TANGAN KANAN , Spo2 : 87% KAKI KIRI ON CPAP PEEP 8 FLOW 8 LPM (5 menit setelah pasang cpap) Lapor hasil babygram
19.45	Advice DPJP PRO RUJUK INDIKASI RUJUK : gagal cpap pro niv , pro pemberian surfaktan , pro perawatan subspesialistik neonatologi
20.58	Lapor kondisi pasien ke RS Rujukan Lavalette
21.25	Balasan dari RS Lavalette Saran DPJP untuk ke RSSA karena Ventilator masih penuh
21.27	Lapor kondisi pasien ke RS Rujukan DR. SAIFUL ANWAR MALANG
21.36	Lapor kondisi pasien ke RS Rujukan RSUD BANGIL
30-07-2025	Lapor kondisi pasien ke RS Rujukan RSUD NOTOPURO SIDOARJO
02.30	
07.26	Balasan RS Rujukan DR. SAIFUL ANWAR MALANG Saran DPJP untuk ke RS rujukan lain karena ruang NICU masih penuh
07.31	Lapor kondisi pasien ke RS Rujukan RSIA HERMINA MALANG
07.51	Balasan dari RS Hermina Malang Pasien masih menunggu dikonsulkan DPJP Konsultan
08:20	Pasien ACC diterima di RS Hermina

09:02	Konfirmasi keberangkatan ke RS Hermina Kondisi bayi k/u lemah sesak(+) retraksi (+) sianosis(+)tangis (+) N: 167 x/mnt S: 36,8 C RR: 71x/mnt SPO: 87-97% on Neopuff 8 lpm Perawat pendamping Wiwik TTV selama di ambulance: 09.15 N : 146X/ Menit , rr : 70 x /menit , Spo2 : 97 % S: 36,8 C 09.30 N : 148X/ Menit , rr : 69 x/menit , Spo2 : 96 % S : 36,7 C 09.45 N : 157X/ Menit , rr : 70x/menit , Spo2 : 97 % S : 36'8 C 10.00 N : 164X/ Menit , rr : 71x/menit , Spo2 : 96 % S : 36'7 C
10:10	Sampai di RS Hermina TTV pasien K/U lemah tangis(+)sianosis(+)tangis (+)sesak(+) N:165x/mnt S:36,9 C RR:71x/mnt SPO: 100% on Neopuff 8 lpm

16.08	Injeksi Cefotaxim 125mg IV
17.00	Injeksi gentamicin 5 mg IV Lapor kondisi bayi ke DPJP TTV: k/u lemah Nadi: 154 x/ menit Suhu: 36,9 RR: 67 x/ menit Spo2: on O2 CPAP 58 % tangan kanan 53 % tangan kiri Sianosis (+), retraksi (+), saturasi turun hingga 59% GDA : 109mg/DI Tindakan yang dilakukan: Pasang Neopuff 30% PEEP 5
18:58	Balasan DPJP : Coba VTP 1 menit menggunakan O2 10 LPM
19.02	Lapor kondisi bayi TTV : N : 156 x/mnt RR : 67 x/mnt S : 36,8 C SPO2 : 98% on VTP 10LPM (Tangan Kanan) 98 % on VTP 10LPM (Kaki Kiri) Sesak (+), retraksi (+), merintih (+) Lapor hasil DL dan GDA bayi

	Hb : 13,5 g/dl Trombosit : 208.000 Leukosit : 15.700 Eosinofil : 3 Basofil : 1 Neutrofil : 60 Limfosit : 22 Monosit : 14 GDA : 50 mg/dl
19.16	Balasan DPJP O2 Cpap Peep 8 Flow 8lpm Evaluasi ulang kondisi 1 jam lagi
19.27	lapor kondisi pasien ke DPJP : TTV: k/u lemah Nadi: 163 x/ menit Suhu: 36,9 RR: 68 x/MENIT Spo2: 86% TANGAN KANAN , Spo2 : 87% KAKI KIRI ON CPAP PEEP 8 FLOW 8 LPM (5 menit setelah pasang cpap) Lapor hasil babygram
19.45	Advice DPJP PRO RUJUK INDIKASI RUJUK : gagal cpap pro niv , pro pemberian surfaktan , pro perawatan subspesialistik neonatologi
20.58	Lapor kondisi pasien ke RS Rujukan Lavalette
21.25	Balasan dari RS Lavalette Saran DPJP untuk ke RSSA karena Ventilator masih penuh
21.27	Lapor kondisi pasien ke RS Rujukan DR. SAIFUL ANWAR MALANG
21.36	Lapor kondisi pasien ke RS Rujukan RSUD BANGIL
30-07-2025 02.30	Lapor kondisi pasien ke RS Rujukan RSUD NOTOPURO SIDOARJO
07.26	Balasan RS Rujukan DR. SAIFUL ANWAR MALANG Saran DPJP untuk ke RS rujukan lain karena ruang NICU masih penuh
07.31	Lapor kondisi pasien ke RS Rujukan RSIA HERMINA MALANG
07.51	Balasan dari RS Hermina Malang Pasien masih menunggu dikonsulkan DPJP Konsultan
08:20	Pasien ACC diterima di RS Hermina
09:02	Konfirmasi keberangkatan ke RS Hermina Kondisi bayi k/u lemah sesak(+) retraksi (+) sianosis(+)tangis (+) N: 167 x/mnt S: 36,8 C RR: 71x/mnt SPO: 87-97% on Neopuff 8 lpm Perawat pendamping Wiwik

	TTV selama di ambulance: 09.15 N : 146X/ Menit , rr : 70 x /menit , Spo2 : 97 % S: 36,8 C 09.30 N : 148X/ Menit , rr : 69 x/menit , Spo2 : 96 % S : 36,7 C 09.45 N : 157X/ Menit , rr : 70x/menit , Spo2 : 97 % S : 36'8 C 10.00 N : 164X/ Menit , rr : 71x/menit , Spo2 : 96 % S : 36'7 C
10:10	Sampai di RS Hermina TTV pasien K/U lemah tangis(+)sianosis(+)tangis (+)sesak(+) N:165x/mnt S:36,9 C RR:71x/mnt SPO: 100% on Neopuff 8 lpm

Mengetahui,
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Sukorejo,



Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep., M.
Kep